Definiciones

Utilizaré las definiciones de la RAE

aborto

1.m. **Acción y efecto de abortar**.
SIN.: fracaso, malogro, frustración.
2. m. **Interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas**.
3. m. Ser o cosa abortados.
4.m. Engendro, monstruo.
SIN.: engendro, monstruo, feto.

abortar

1. intr. Dicho de una mujer o de un animal hembra: **Interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo**. Abortó el hijo que esperaba.
SN.: malparir.
2. intr. Biol. Dicho de un órgano: Desarrollarse parcialmente sin que llegue a ser funcional.
3. intr. Med. Dicho de una enfermedad: Desaparecer antes del término natural.
4. intr. p. us. Dicho de una empresa o de un proceso: Fracasar, malograrse. El intento de repoblación forestal abortó.
5. tr. Interrumpir, frustrar el desarrollo de un plan o proceso. El piloto abortó el despegue.
SIN.: interrumpir, frustrar, truncar, yugular
ANT.: continuar.
6. tr. p. us. Producir o echar de sí algo sumamente imperfecto, extraordinario, monstruoso o abominable.

Etimología

La palabra "aborto" viene del latin *abortus*, formada por:

- El prelijo ab- (privación, separación del exterior de un límite), como en abdomen, abductor, abolir, etc. Se asocia a una raíz indoeuropea apo- (alejar, separar), presente en el griego *ἀπό* (lapo = aparte, fuera, lejos) y las palabras apocrilo. andcone, apocalipsis, apofonia, etc.
- La palabra *ortus* (nacido), compuesta de:
    - La raíz del verbo *oriri* (surgir, nacer, levantarse, aparecer) que nos dio palabras como orientar o origen.
    - El sufijo *-tus* (-to) usado para formar particicios e indicar que ha recibido la acción, como vemos en adulto y absoluto

Entonces entendemos la palabra aborto como **"privación de nacimiento"**.

Nos centramos en el aborto provocado.

eutanasia

1. f. **Intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura**.
2. f. Med. **Muerte sin sufrimiento físico**.

Etimología

Según el DRAE la palabra eutanasia viene de griego εὐθανασία (efthanasia) formada de *εὖ* (ef) “bien” y *θάνατος* (thánatos) “muerte” o sea “el buen morir".

En la obra Μύρμηξ (Mirmix) de Poseidippus of Cassandreia (316 a.C.- 250 a.C.) encontramos esta palabra:

- **’ ὧν τοῖς θεοῖς ἄνθρωπος εύχεται τυχεῖν τῆς εὐθανασίας κρείττον οὐδέν εύχεται -*
- *on tis theis anthropos efjete tijin tis efthanasias kriton uden efjete.*
- *de todo lo que un hombre puede pedir de los dioses la eutanasia es lo mejor*

El significado de esta palabra en la Grecia antigua fue: una muerte honorable y una muerte sin dolor, suave, como describe Homero en su obra.

- *΄΄ θάνατος δέ τοι ἐξ ἁλὸς αὐτῷ ἁβληχρός μάλα τοῖος ἐλεύσεται, ός κε σε πέφνη γήρα ύπο λιπαρῷ ἀρήμενον. ΄*
- *thanatos de ti ex alos afto avlijros mala tios elefsete, os ke se pefni gira ipo liparo arimenon.*
- *Y entonces te llegará la muerte fuera del mar, una muerte muy suave que te consuma agotado bajo la suave vejez*
- *La Odisea, canto XI, verso 134.*

Podemos leer el significado moderno:
“Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él”.

El médico griego Hipócrates (460 a.C. 370 a.C.) en su Juramento Hipocrático prohíbe a los médicos la eutanasia activa y la ayuda para cometer suicidio.

- ** Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ομοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω΄΄.
- U doso d uden farmakon udeni etithis thanasimon ude ifigisome ksimvuliin tiinde. Omios de ude gineki pesson fthorion doso"
- A nadie daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores'".

También podemos hacer la radicación de la palabra *εὐθανασία* de esta manera:

- La palabra *εὖ* (*eu* = bien) se vincula a la raíz indoeuropea indoeuropea “esu” (bueno).
- La palabra *θάνατος* (*thanatos* = muerte) se relaciona con una raíz indoeuropea “dheu” (subir en forma de nube o vapor).
- El sufijo *σις* (*-sis* = acción).
- El sufijo -*ία* (*-ía* = cualidad).

En el campo médico la **eutanasia** se diferencia de la **ortotanasia**, en que en la **eutanasia los médicos intencionalmente causan la muerte** al paciente cuando está sufriendo de una enfermedad mortal que no tiene remedio. Mientras que en la **ortotanasia**, los médicos **tratan de disminuir el dolor**, pero no aceleran la muerte del paciente. Estas dos se contrastan con la distanasia, en la cual los médicos prolongan innecesariamente la vida y el sufrimiento del paciente.

Datos

Aborto

Historia
La interrupción voluntaria del embarazo, o aborto inducido, en España está regulada por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley de 2010 había despenalizado la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas del embarazo. Una regulación anterior -Ley Orgánica 9/1985- había despenalizado el aborto en varios supuestos.

Actualmente:

- En las primeras 14 semanas: la decisión es libre, siempre y cuando se halla informado a la embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Siendo necesaria la espera de, al menos, 3 días tras la entrega de la documentación para proceder a la interrupción por el método elegido.
- Entre las 14 y 22 semanas: el aborto es permitido previo diagnóstico médico que lo justifique, como malformaciones en el feto o enfermedad grave de la embarazada. Este diagnóstico debe ser confirmado por dos especialistas independientes.
- Posterior a las 22 semanas: solo es posible la interrupción del embarazo en los siguientes casos:
    - Anomalías fetales incompatibles con la vida, con dictamen emitido por algún especialista que no sea quien realizará el procedimiento de interrupción.
    - Detección de enfermedad fetal extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, confirmada por un comité médico.

Datos INE 2024 España:

Motivo, semanas de gestación y recurrencia

El motivo principal de la interrupción fue la decisión voluntaria de la mujer, en el 94,62% de los casos. El 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

En cuanto al momento de la gestación, el 76,58% de las intervenciones se realizaron antes de las ocho semanas. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%. Respecto a la recurrencia, el 67,6% de las mujeres no habían tenido abortos voluntarios anteriores, frente al 66,99% en 2023.

Datos OMS 8 de diciembre de 2025:

Datos y cifras

Seis de cada diez embarazos imprevistos se interrumpen voluntariamente.
El aborto es una intervención de salud que se practica con frecuencia. Es muy seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS y adecuado para la duración del embarazo, y lo practica una persona que posee las capacidades necesarias.
No obstante, **alrededor del 45 % de los abortos se realizan en condiciones de riesgo.**

El aborto peligroso es una causa importante y prevenible de morbimortalidad materna, que puede dar lugar a complicaciones físicas y psíquicas para las mujeres, así como a perjuicios sociales y económicos tanto para ellas como para las comunidades y los sistemas de salud.
La falta de acceso a una asistencia segura, oportuna, asequible y respetuosa para el aborto es un grave problema desde el punto de vista de la salud pública y de los derechos humanos.

Panorama general

Cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. Seis de cada diez (61 %) de los embarazos imprevistos y tres de cada diez de todos los embarazos (29 %) se interrumpen de forma voluntaria (1).

La atención integral para el aborto está incluida en la lista de intervenciones esenciales de la atención de salud que la OMS publicó en 2020. El aborto, ya sea farmacológico o quirúrgico, es una intervención sencilla que pueden practicar de manera segura y eficaz una amplia variedad de trabajadores de la salud. Durante las 12 primeras semanas de gestación, la embarazada puede practicar por sí misma el aborto farmacológico sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud (por ejemplo, en su domicilio), sea el proceso completo o parte de él. No obstante, para ello debe tener acceso a información precisa y medicamentos de calidad, y contar con el apoyo de un trabajador de la salud cualificado en caso de que lo necesite o lo solicite.
Una atención integral del aborto debe incluir la provisión de información, la práctica del aborto y la atención posterior. La práctica del aborto incluye el aborto provocado (es decir, la interrupción voluntaria de un embarazo por medios farmacológicos o quirúrgicos), la asistencia en caso de pérdida del embarazo (por ejemplo, el aborto espontáneo, el aborto retenido y la muerte fetal intrauterina) y el tratamiento de las complicaciones tras un aborto.
Esta nota descriptiva se centra en la asistencia relacionada con el aborto provocado.

Eutanasia

Historia

La eutanasia en España es legal desde del 25 de junio de 2021, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tras ser aprobada por las Cortes Generales el 18 de marzo de 2021. Dicha ley despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse. De esta forma España se convirtió en el sexto Estado del mundo en reconocer el derecho a la eutanasia.

Artículo 143 del Código Penal

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.

Datos INE 2024 España:

Derecho a la eutanasia en España: 426 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024

En 2024 se registraron 905 nuevas solicitudes de prestación de ayuda para morir, y se finalizaron 929 procesos en total, cifra que incluye tanto solicitudes presentadas ese año como otras iniciadas en ejercicios anteriores.

Del total de procesos finalizados, el 45,86% concluyó con la prestación de ayuda para morir, el 33,15% correspondió a personas que fallecieron durante la tramitación, el 15,18% fueron solicitudes denegadas y el 5,81% fueron revocadas por la persona solicitante.

Desde la entrada en vigor de la LORE en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De estas solicitudes, 1.123 (46%) terminaron en una prestación efectiva.

Catecismo de la Iglesia Católica

TERCERA PARTE > SEGUNDA SECCIÓN > CAPÍTULO SEGUNDO
ARTÍCULO 5 EL QUINTO MANDAMIENTO

> «No matarás».
> «Habéis oído que se dijo a los antepasados: "No matarás"; y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal».

2258 "La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente".

1. EL RESPETO DE LA VIDA HUMANA
   a. **El aborto**

2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida.

> «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado».
> «Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra».

2271 Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral.

> «No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido».
> «Dios (…), Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables».

2272 La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. "Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae", es decir, "de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito", en las condiciones previstas por el Derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad.

2273 El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación:

"Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos

fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte".

"Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho (…) El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, a quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos".

2274 Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, "si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación (…) Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto: un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte".

2275 Se deben considerar "lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual".

«Es inmoral (…) producir embriones humanos destinados a ser explotados como "material biológico" disponible».

"Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad".

b. La eutanasia

2276 Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible.

2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable.

Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre.

2278 La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el "encarnizamiento terapéutico". Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.

2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados.

El aborto

1. “La situación de mi nacimiento no determina mi valía”
2. “¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?” Papa Francisco
3. El sufrimiento concebido únicamente como algo negativo y no deseable
4. Mi cuerpo, mi decisión.
5. Salud, violación…
6. Datos sobre abortos provocados en el mundo/España y razones

La eutanasia

1. El suicidio no está castiagado en España, sin embargo la inducción y la cooperación a ello sí.
2. La eutanasia se distingue del suicidio en la forma de acabar con la vida, ya que es controlada y estudiada por profesionales para llegar a considerarla la mejor opción
3. Caemos no solo en el error del fin justifica los medios, sino en el medio justifica el fin. Es de decir, el suicidio está visto como algo malo y rechazable pero cuando se hace de cierta manera con ciertas intenciones, está bien
4. medicina: f. Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. → enfermedad: f. Estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo.Ant.:salud.

EMBARAZO PELIGROSO SIN SALIDA

La Iglesia Católica tiene una postura muy clara y coherente internamente, aunque para muchas personas resulte difícil o polémica:

Nunca es moralmente lícito matar directamente al bebé, ni siquiera para salvar la vida de la madre. Pero sí es lícito realizar un tratamiento médico necesario para salvar a la madre aunque, como consecuencia indirecta e inevitable, el bebé muera.

La diferencia clave está en la intención y el tipo de acción.

Principio central: el “doble efecto”

La Iglesia usa lo que se llama el principio del doble efecto, que dice:
Una acción puede ser moralmente permitida si:

1. La intención es buena (salvar a la madre).
2. La acción en sí no es matar al bebé.
3. La muerte del bebé no es el medio para salvar a la madre, sino una consecuencia no deseada.
4. No hay otra alternativa

<u>Contraargumentos al aborto</u>

1. Autonomía corporal

> “La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.”

Contraargumento:

* El embrión o feto no es solo parte del cuerpo de la madre, sino un ser humano distinto con ADN propio.
* La libertad personal termina donde comienza la vida de otro.

* No todo lo que depende de mi cuerpo es moralmente mío para destruirlo (ej.: un bebé recién nacido también depende totalmente de la madre).

2. Salud física y mental
> “El embarazo puede dañar la salud de la madre.”

Contraargumento:
* En la mayoría de los casos, el aborto no es médicamente necesario para salvar la vida de la madre; existen tratamientos alternativos.
* Quitar una vida no es una terapia.
* El daño psicológico del aborto también puede ser grave (culpa, depresión, trauma).

3. Calidad de vida del futuro hijo
> “Mejor no nacer que sufrir.”

Contraargumento:
* Nadie puede decidir que otra vida no merece ser vivida.
* Este argumento implica que las personas con discapacidad valen menos.
* El sufrimiento no elimina la dignidad humana.

4. Contexto social y económico
> “No hay condiciones para criar a un hijo.”

Contraargumento:
* La pobreza no justifica quitar la vida.
* La solución debería ser apoyar a la madre, no eliminar al hijo.
* Si esto fuera válido, también justificaría eliminar a personas pobres ya nacidas.

5. Aborto como hecho social inevitable
> “Ocurre igual, mejor legalizarlo.”

Contraargumento:
* Que algo ocurra no lo hace moralmente correcto.
* También hay robos o corrupción, y no por eso se legalizan.
* La ley debe proteger a los más vulnerables, no facilitar su eliminación.

6. El embrión no es persona
> “No tiene conciencia.”

Contraargumento:
* La dignidad no depende de la conciencia actual, sino de ser humano.
* Un recién nacido tampoco tiene conciencia desarrollada.
* La biología muestra que desde la fecundación hay un individuo humano completo en desarrollo.

<u>Contraargumentos a la eutanasia</u>
1. Derecho a morir con dignidad
> “Cada uno decide cuándo morir.”

Contraargumento:
* La dignidad no se pierde por estar enfermo.
* Legalizar la eutanasia transmite que algunas vidas ya no valen la pena.
* Puede generar presión social sobre enfermos y ancianos.

2. Alivio del sufrimiento extremo
> “Es un acto de compasión.”

Contraargumento:
* La compasión auténtica es acompañar y cuidar, no matar.
* Los cuidados paliativos pueden aliviar el dolor sin provocar la muerte.
* Eliminar al que sufre no elimina el sufrimiento, elimina al que sufre.

3. Autonomía personal
> “Soy dueño de mi vida.”

Contraargumento:
* La sociedad limita decisiones cuando afectan a la vida (suicidio asistido, drogas, etc.).
* La vida es un bien que trasciende la decisión individual.
* La autonomía no es absoluta.

4. Respeto a la voluntad del paciente
> “Si lo pide, debe respetarse.”

Contraargumento:
* El deseo de morir suele surgir de la depresión, el miedo o la soledad.
* No siempre es una decisión libre y estable.
* El deber médico es curar y cuidar, no provocar la muerte.

5. Evitar tratamientos inútiles
> “No prolongar artificialmente la vida.”

Contraargumento:
* Rechazar tratamientos desproporcionados es distinto de provocar la muerte.
* Existe una diferencia ética clara entre dejar morir y matar activamente.

6. Enfermedades degenerativas
> “Prefiero morir antes de perder la autonomía.”

Contraargumento:
* La vida no vale por su productividad o independencia.
* Este argumento desvaloriza a las personas con discapacidad.
* Abre la puerta a que terceros decidan quién merece vivir.

Ambos parten de que hay vidas que no merecen ser vividas si causan sufrimiento o dependencia.

* Toda **vida humana** tiene **valor intrínseco**.
* La solución ética es **acompañar, cuidar y proteger**, no eliminar.
* Legalizarlos crea una “pendiente resbaladiza” hacia **abusos**.